



焦虑障碍概述

作者: [John W. Barnhill, MD](#), New York-Presbyterian Hospital

Reviewed By [Mark Zimmerman, MD](#), South County Psychiatry

已审核/已修订 8月 2023 | 修改的 1月 2026

焦虑是一种紧张、担忧或不安的感觉，是人的正常体验。它也存在于一系列广泛的精神健康疾病之中，包括广泛性焦虑障碍、惊恐障碍和恐惧症。虽然这些疾病各不相同，但是它们都特征性地表现出痛苦和功能障碍，特别是与焦虑和恐惧相关。

- 在经历焦虑时，患者通常还会出现身体症状，包括呼吸短促、头晕、出汗、心跳加快和/或震颤。
- 焦虑障碍通常会大大改变人们的日常行为，包括导致他们回避某些事物和情境。
- 这些疾病根据标准医学标准进行诊断。
- 药物、心理治疗或两者结合，对大多数焦虑障碍患者有实质性帮助。

焦虑是对威胁和心理应激的正常反应。正常的焦虑有一个恐惧的来源并是一种重要的生存本能。当人面临一个危险的情况，焦虑可触发战斗或逃跑反应。伴随这个反应机体产生一系列生理机能改变，如增加向心脏和肌肉血供，提高机体能量代谢，增强力量以应对威胁生命的情况，如躲避猛兽的侵袭或迎战对手。焦虑可以通过激励患者做好准备、练习和排练来帮助患者适应较普通的压力源。它甚至可以促使患者谨慎地接近有潜在危险的情况。

但是，焦虑在下列情况下被视为一种疾病

- 在不适当的时间发生
- 经常发生
- 过于强烈而持久，以致于干扰人的正常活动（即，导致适应不良的行为）

焦虑障碍比任何其他精神健康疾病更普遍，约三分之一的美国成人在人生的某个时刻受焦虑障碍的影响。严重焦虑可持续数年，并开始使患者本人感到正常。因此（以及其他一些原因），焦虑障碍通常未得到诊断或治疗。它们也可能与[自杀念头和自杀企图](#)有关。

焦虑障碍有很多类型：

- [分离焦虑障碍](#)
- 选择性缄默症
- [特定恐惧症](#)（动物、自然环境、血液-注射-损伤、情境、其他情况）
- [社交焦虑障碍](#)

- [惊恐障碍](#)
- [广场恐惧症](#)
- [广泛性焦虑障碍](#)
- 物质诱发/药物诱发的焦虑障碍
- 其他疾病引起的焦虑
- 其他特定焦虑障碍（当患者有显著症状但不符合任何特定焦虑障碍的标准时适用）

这些疾病大多在成年期发生，但分离焦虑和选择性缄默症通常始于儿童期。医生还会评估因物质诱发/药物诱发焦虑障碍和因其他疾病引起的焦虑而出现严重焦虑的患者。

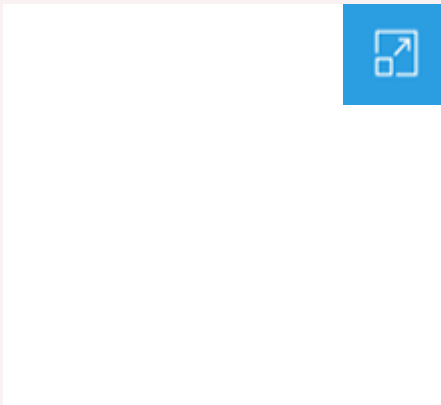
其他常伴有显著焦虑的疾病包括[急性应激障碍](#)、[适应障碍](#)和[创伤后应激障碍\(PTSD\)](#)。这些疾病是由创伤或应激性经历引起的（见[创伤和应激相关障碍概述](#)）。

焦虑障碍往往与其他医学疾病和精神健康疾病同时发生：

- 精神障碍：[抑郁症](#)、[双相障碍](#)、[物质使用障碍](#)、[人格障碍](#)和其他[焦虑障碍](#)
- 医学疾病：[冠状动脉疾病](#)、[哮喘](#)、[偏头痛](#)和[关节炎](#)

焦虑如何影响人们的行为表现？

焦虑对行为表现的作用可以用一条曲线来表示。随着焦虑水平的增加，运行效率也相应增加，但当达到一个最高点后反而会随着焦虑水平的进一步增加而下降。在曲线最高点之前，焦虑是积极适应性的，它帮助人准备应付危机和提高他们的功能。超过顶峰之后，焦虑被认为是适应不良的，因为它可使人产生痛苦并损伤他们的功能。



焦虑障碍的原因

焦虑障碍的病因尚不完全清楚，但可能涉及以下内容：

- 环境（如遇到创伤性事件或压力）
- 遗传因素（包括焦虑障碍家族史）

- 身体状况（例如，甲状腺功能亢进、心力衰竭）
- 药物、非法药物或其他物质（如咖啡因、皮质类固醇、可卡因）

焦虑在心理水平上被看做是一种对外界应激（如重大关系的破裂或暴露于威胁生命的灾难）的反应。然而，许多人在没有可识别的触发因素的情况下会出现焦虑障碍。

当一个人对压力因素反应过度或难以承受某些事件时，焦虑障碍就可能发生。例如，有些人觉得在一群人面前讲话很兴奋。而另一些人却感到害怕，并变得紧张不安，出现诸如出汗、恐惧、心率加快和颤抖等症状。因此，后者即使面对很少的人也可能尽量避免讲话。

焦虑倾向于发生于家庭成员中。医生认为这种趋势有的是遗传性的，但是有的可能是与焦虑的人生活在一起所习得的。

您知道吗.....

- 焦虑障碍是最常见的精神健康疾病。
- 焦虑障碍患者比其他人更易患抑郁症。

由疾病或药物引起的焦虑

疾病或药物的使用或停用（戒断）也可导致焦虑。可引起焦虑的疾病包括：

- 心血管系统疾病，如[心力衰竭](#)和[心律失常](#)（心律不齐）
- 激素（内分泌）疾病，如肾上腺过度活跃（[肾上腺功能亢进](#)）或甲状腺功能过度活跃（[甲状腺功能亢进](#)）或一种称为[嗜铬细胞瘤](#)的激素分泌肿瘤
- 肺部（呼吸系统）疾病，如[哮喘](#)和[慢性阻塞性肺病](#) (COPD) 及[睡眠呼吸暂停](#)

当患者有一种他们害怕会使他们病重甚至导致死亡的疾病时，他们有某种程度的焦虑是正常的。对于任何个人或疾病来说，焦虑程度多少是合理或过度没有正确的答案。但是，如果它引起痛苦或干扰日常功能，患者可能会患有焦虑障碍并需要治疗。

甚至发热也可以引起焦虑。

能诱发焦虑的药物或其他物质包括：

- [饮酒](#)
- 兴奋剂（如[安非他命](#)）
- 咖啡因
- 在一些人中，[大麻制品](#)（大麻）
- [可卡因](#)
- [MDMA（摇头丸）](#)
- 许多处方药，如皮质类固醇
- 一些非处方药，如抗组胺药和减充血药

- 一些非处方的减肥药，如那些含有瓜拉那、咖啡因成分或两者兼而有之的成药

[酒精](#)或[镇静剂](#)戒断会导致焦虑，如苯二氮卓类药物（用于治疗焦虑障碍；参见表格[用于治疗焦虑障碍的药物](#)相应条目），也可导致其他症状，如[失眠](#)和烦躁。

许多人在 COVID-19 疫情大流行期间出现焦虑、创伤和应激相关障碍，有些人在该时期后继续有与疫情大流行或 COVID-19 感染有关的焦虑。引起恐惧和焦虑或使其加重的因素包括疾病或死亡风险、呼吸短促等症状、皮质类固醇治疗、亲人患病或死亡、需要采取预防措施（口罩、洗手、闭锁）以及许多其他个人或社会因素（如日常事务的重大变化、社交隔离，或学校、工作、家庭或社区的变化）。此外，一些专家认为 COVID-19 感染可诱发宿主免疫反应，导致神经精神症状（例如，焦虑、情绪变化、神经肌肉功能障碍）。这些神经精神反应可能是急性的，也可能是 COVID 长期症状的一部分。

由于对死亡、疼痛和呼吸困难的恐惧，患有危及生命的疾病的人也可能会出现焦虑（参见[致死性疾病期间的症状：抑郁和焦虑](#)）。

焦虑障碍的症状

焦虑障碍可以突然发生如惊恐障碍，也可以经过数分钟，数小时或数天逐渐发生。焦虑持续时间长短不一，从几秒到几年。焦虑强度有轻有重，从只表现为难以察觉的不安到出现呼吸困难、晕厥、心跳加快和颤栗（震颤）等反应的[惊恐发作](#)。

焦虑障碍可以诱发许多身体症状，包括

- 恶心、呕吐、腹泻
- 呼吸短促、窒息
- 头晕、晕厥、出汗、忽冷忽热
- 心悸、心动过速
- 肌肉紧张、胸痛或胸闷

患者可以记录详细的惊恐或担忧日记，以写下症状描述和与症状相关的因素（日期、时间、任何已知的焦虑原因），这可能有用。仅凭记忆记住细节并在事后向医生报告可能有些困难。最成功的治疗策略通常依靠解决具体细节问题。

焦虑障碍使患者痛苦不已并严重影响正常生活，以至于最终导致[抑郁](#)。焦虑障碍患者（除去非常[特定的恐惧](#)，例如害怕蜘蛛）同时患抑郁症的几率是无焦虑患者的 2 倍以上。有时患者首先出现抑郁，然后出现焦虑障碍。患者可能会尝试通过饮酒或使用毒品来治疗焦虑，而因此出现[物质使用障碍](#)。

焦虑障碍的诊断

- 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

确定何时焦虑严重到足以被认为是一种疾病可能会很复杂。每个人耐受焦虑的能力不同，导致什么样的焦虑算异常，有时难以确定。医生通常采用下面这些已经确立的具体诊断标准：

- 焦虑非常令人痛苦。
- 焦虑干扰功能。
- 焦虑持续时间长或反复出现。

医生寻找可能引起焦虑的其他疾病，例如[抑郁症](#)或[睡眠障碍](#)。医生还会询问亲属是否有类似的症状，因为焦虑障碍往往有家族史。

医生也进行体格检查。为排除可导致焦虑的其他疾病，可能需要做血液化验及其他检查。

焦虑障碍的治疗

- 如果发现疾病，则治疗病因
- 受教育程度
- 放松技巧
- 心理治疗
- 药物

明确诊断十分重要，因为根据不同类型的焦虑障碍采用不同的治疗方法纠正。另外，焦虑障碍必须与其他精神疾病伴发的焦虑状态进行区分，已选择适当的治疗方法。

如果焦虑的病因是另一种疾病或药物，医生将注重于纠正病因。通过治疗躯体疾病或停药时间足够长、药物戒断症状消退后，焦虑障碍常会自行缓解。如果纠正原发因素后焦虑仍持续存在，可使用抗焦虑药物或心理治疗（如行为治疗）。

许多焦虑障碍患者自行使用酒精、大麻和苯二氮卓类药物（抗焦虑药）等物质来治疗焦虑。他们不仅会羞于向医生承认这一点，而且可能不愿意放弃使用这些物质，直到他们的医生找到可行的替代品。以这种方式自我治疗是危险的，并可能导致使用后再次出现焦虑的恶性循环，然后又需要反复自我治疗。

若焦虑障碍诊断成立，药物治疗或[心理治疗](#)（如[行为治疗](#)）单独治疗或联合治疗，均能减轻大多数患者的痛苦和功能障碍。可使用不同类型的心理治疗，例如认知行为治疗、基于正念的减压、催眠和支持性心理治疗。

苯二氮卓类药物（如地西洋）为常用处方药。对于许多人而言，选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 等[抗抑郁药](#)对焦虑障碍的效果和对抑郁症一样好。

所有焦虑障碍都可能与其他精神健康疾病一起发生。医生需要治疗所有与焦虑相关的疾病。例如，焦虑障碍常与[酒精使用障碍](#)一同发生。如果治疗酒精使用障碍而不治疗焦虑，很可能不会有效，因为患者可能会使用酒精来减轻焦虑。另一方面，在不解决酒精问题的情况下治疗焦虑可能也不会成功，因为每日的血液酒精含量改变可导致焦虑水平波动。

表格			
治疗焦虑障碍的药物			
药物	临床应用	一些副作用	注释

药物	临床应用	一些副作用	注释
苯二氮䓬类药物			
阿普唑仑			最常用的抗焦虑药物
氯氮卓			通过减少脑区神经活性而使精神和躯体放松
氯硝西泮	<u>广泛性焦虑障碍</u>	嗜睡、记忆问题、共济失调、反应迟缓	起效快，有时可在 1 小时内起效
Clorazepate	<u>惊恐障碍</u>		
安定	<u>恐惧障碍</u>	可能导致药物依赖	
劳拉西泮			不应与导致嗜睡的其他药物一起使用
奥沙西泮			
Buspirone	<u>广泛性焦虑障碍</u>	晕厥和头痛	不会引起困倦或与酒精产生相互作用 不会引起药物依赖 起效缓慢，可能需要数周
抗抑郁药*			
SSRI（如依他普仑）	<u>广泛性焦虑障碍</u>		
SNRI（如文拉法辛）	<u>惊恐障碍</u>	参见表格 <u>用于治疗抑郁症的药物</u>	参见表格 <u>用于治疗抑郁症的药物</u>
单胺氧化酶抑制剂 (MAOI)	<u>恐惧障碍</u>		
TCA（如氯丙咪嗪）	<u>创伤后应激障碍</u>		
其他抗焦虑药物			
Buspirone	<u>广泛性焦虑障碍</u>	晕厥和头痛	不会引起困倦或与酒精产生相互作用 不会引起药物依赖 起效缓慢，可能需要数周
* 不同抗抑郁药其临床适应症不同。 MAOI = 单胺氧化酶抑制剂；SNRI = 选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂；SSRI = 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂；TCA = 三环类抗抑郁药。			

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

[美国国家精神卫生研究所，焦虑障碍](#)：所有焦虑障碍各方面的一般信息，包括危机热线和教育计划